حیطه ابزاربرادن	معیارهای ارزیابی برادن	امتیاز
A ارزیابی سطح هوشیاری Sensory Perception	کاملا محدود :عدم پاسخ به محرک دردناک(به دلیل کاهش هوشیاری دریافت سداتیوکاهش توانایی احساس درد در بدن)	۱
	خیلی محدود : پاسخ به تحریکات دردناک (عدم برقراری ارتباط بی قراری محدودیت در احساس درد بیش از نصف بدن)	۲
	کمی محدود :گاها به دستورات کلامی پاسخ میدهد.	۳
	بدون محدودیت : به دستورات کلامی پاسخ داده ودردرا بیان میکند.	۴
B : ارزیابی رطوبت پوست Moisture	رطوبت مداوم : ملحفه ولباس بیمار،همواره مرطوب میباشد.	۱
	خیلی مرطوب : ملحفه ها درهرشیفت ،به دلیل خیس بودن تعویض میشود.	۲
	گاهی مرطوب : ملحفه ها حداقل یکباردرروزبه دلیل خیس بودن ،تعویض میشود.	۳
	بندرت مرطوب : پوست معمولا خشک است ،ملحفه ها طبق روتین بدون خیس بودن تعویض میشود.	۴
C : ارزیابی میزان فعالیت فیزیکی Activity	محدود به تخت : استراحت مطلق) – CBR (بدون تحرک	۱
	محدود به صندلی : باید با کمک صندلی چرخدارحرکت کند.	۲
	گاهی راه می رود : گاهی در طول روز باکمک راه میرود (اکثرساعات را در تخت می گذراند.)	۳
	مکررا راه می رود : مرتبا به طورمستقل راه میرود.	۴
D : ارزیابی توانایی درتغییرپوزیشن Mobility	کاملا بی حرکت : بدون کمک حتی قادر به تغییرات اندک در وضعیت بدن یا اعضا نمی باشد.	۱
	حرکت بسیار محدود : گاهی تغییرات کمی را به بدن یا اعضا باکمک می دهد.	۲
	اندکی محدود : بدون کمک تغییرات اندکی را بطور مکرر در بدن و اعضایش ایجاد می کند	۳
	بدون محدودیت : بدون کمک مکررا ومستقل پوزیشن خود را تغییر می دهد.	۴
E : ارزیابی تغذیه Nutrition	بسیار کم : تغذیه بیمارکاملا ناکافی است ممکن است روزها NPO باشد	۱
	ناکافی : تغذیه ناکافی ازراه دهان یا ازطریقNGT	۲
	کافی : تغذیه کافی به طوری که بیش از نصف غذایش را میخورد.	۳
	عالی : تغذیه کاملا خوب ،همه وعده های غذایی را به طور کامل میخورد.	۴
F : ارزیابی اصطکاک وسایش پوست Friction & Shea	مشکل دار : همواره موقع جابجایی روی ملحفه کشیده میشود.	۱
	مشکل احتمالی : موقع جابجایی گاها کمک میکندولی باز هم قسمتهایی از بدن بیمارروی ملحفه کشیده میشود.	۲
	بدون مشکل : به طورکامل قادربه بلندکردن بدن خود میباشد وروی ملحفه سائیده نمیشود.	۳

نتایج ارزیابی باابزاربرادن				
خطربسیاربالا	۶-۹	(امتیاز در بیماران مختلف جهت تشخیص خطر ایجاد زخم فشاری)	امتیاز در بیماران عادی	کمتر یا مساوی ۱۶
خطربالا	۱۰-۱۲		امتیاز در بیماران بخشهای ویژه	کمتر یا مساوی ۱۵
متوسط	۱۳-۱۴		امتیاز در بیماران مسن	کمتر یا مساوی ۱۸
پیشگیرانه	۱۵-۱۸	توجه : نتیجه ارزیابی ریسک ایجادزخم بستردرکاردکس بیمارثبت شود.		
بدون خطر	۱۹-۲۲	ارزیابی ریسک درکلیه شیفتها قابل پیگیری است وامکان تغییر آن با توجه به شرایط متغییر مددجو راباید مد نظرقرارداد.		

ابزار مورس در ارزیابی ریسک سقوط بیمار

ارزیابی ریسک سقوط بیمار(مورس Morse Fall Risk Assessment)			
ریسک فاکتور	معیار		امتیاز
وجود سابقه افتادن بیمار (سه ماهه گذشته)	بله خیر		۲۵ ۰
تشخیص ثانویه (داشتن بیش ازیک بیماری)	بله خیر		۱۵ ۰
وسایل کمک حرکتی	استفاده از پایه مبل و صندلی(برای برخاستن و حرکت کردن)		۳۰
	واکر، عصا ،چوب زیربغل کمک گرفتن از پرستار، صندلی چرخدار،استراحت مطلق، عدم استفاده ازابزارکمک حرکتی		۱۵ ۰
داشتن سرم یا هپارین لاک	بله		۲۰
	خیر		۰
وضعیت ذهنی	سنجیدن پاسخ بیمار:آیابه تنهایی میتواندبه سرویس بهداشتی برودیا نیازبه کمک دارد؟		
	محدودیت ها را فراموش می کند وباشرایطش همخوانی نداشت به توانایی های خود آگاهی دارد و با شرایطش همخوانی دارد		۱۵ ۰
الگوی گام برداشتن وحرکت	مختل((:گام برداشتن ناهماهنگ،مشکل دربلندشدن ازصندلی وتلاش برای بلندشدن بافشاردستها برروی صندلی ،سرپائین ونگاه به زمین ،چنگ زدن به وسایل وعدم توانایی بدون کمک گرفتن از دیگران))		۲۰
	ضعف درحفظ تعادل((:خمیدگی ولی توانایی دربلندکردن سرحین راه رفتن،گامهای کوتاه وضعیف بدون ازدست دادن تعادل حین راه رفتن میباشد))		۱۰
	طبیعی((: بی حرکتی واستراحت درتخت ،قدم برداشتن قاطعانه با سرراست وروبه جلو وبازوها درکناربدن ودرنوسان آزاد))		۰
نتایج ارزیابی ریسک سقوط بیمار	ریسک بالاوپرخطر	۵۱ وبیشتر	توجه : نتیجه ارزیابی درکاردکس بیمارثبت شود.
	ریسک متوسط وخطرمتوسط	۲۵-۵۰	ارزیابی این ریسک درکلیه شیفتها قابل پیگیری است
	ریسک پائین وکم خطر	۰-۲۴	وباتغییرشرایط بیمارامکان تغییرآن وجوددارد.

واحد ایمنی بیمارستان

شهید دکتر چمران فردوس

معیار ولز جهت ترومبوز آمبولی وریدی

Wells Criteria VTE (معیار ولز جهت ترومبوز آمبولی وریدی)					
یافته های بالینی برای DVT	نمره	نمره اکتسابی	یافته های بالینی برای آمبولی ریوی -PTE	نمره	نمره اکتسابی
جراحی و یا صدمه یا گچ دراندام تحتانی –پارزی یا پارالایزی	+۱		وجود علایم بیماری DVT	+۳	
بستری در تخت بیش از سه روز یا جراحی بزرگ در چهار هفته قبل	+۱		تشخیص افترالی دیگری که علایم بیمار را توجیه کند نداشته باشیم	+۳	
تندرنس در مسیر ورید های پشت زانو یا رانی	+۱		ضربان قلب بالای ۱۰۰	+۱/۵	
تورم یک عضو	+۱		بی حرکتی بیش از سه روز یا جراحی درچهار هفته اخیر	+۱/۵	
ادم گوده گذار دراندام مبتلا	+۱		سابقه قبلی از TE و DVT	+۱/۵	
تورم بیشتر از سه cm یک پا نسبت به پای دیگر در ۱۰ سانتی متری زیر زانو	+۱		وجود خلط خونی	+۱	
تورم عروقی محیطی که ناشی از واریس نباشد	+۱		بدخیمی حاد یا درمان شده در طول شش ماه قبل یا درمان تسکینی	+۱	
داشتن سابقه DVT قبلی	+۱				
بدخیمی حاد یا درمان شده که شش ماه قبل بوده است	+۱				
تزریق وریدی دارو	+۳				
تشخیص جایگزین با احتمال بیشتری نسبت به DVT	-۱				
۰-۱ احتمال کم ۱-۲ ۰-۲احتمال متوسط ۸-۳ ۰-۳احتمال بالا	●		۲ > نمره احتمال کم ۶-۲ احتمال متوسط ۶< نمره احتمال بالا	●	

واحد ایمنی بیمارستان
شهید دکتر چمران فردوس

معیار ولز جهت ترومبوز آمبولی وریدی

بیماران با ریسک بالا :

سن بالای ۶۰- سال – سن بین ۴۰-۶۰ و دارای یک فاکتور خطر دیگر ، سابقه VTE درافراد خانواده یا خود بیمار – چاقی – انعقادپذیری اکتسابی یا ارثی – بیماریهای زمینه ای مثل بیماری قلبی – عفونت ، سکته های اخیر بیماریهای التهابی – جراحی سر فمور – آرتروپلاستی زانو – شکستگی لگن – ترومای شدید – صدمات نخاعی یا اعمال جراحی سرطان

بیماران با ریسک پایین :

سن کمتر از ۴۰ سال – مدت زمان بیهوشی کمتر از ۳۰ دقیقه

بیماران با ریسک متوسط :

بیمارانی که تحت عمل جراحی کوچک قرار گرفته است ولی سن بین ۴۰-۶۰ سال دارند و به بیهوشی بیشتر از ۳۰ دقیقه نیاز دارند. قفسه صدری –جراحی اعصاب

واحد ایمنی بیمار بیمارستان
شهید دکتر چمران فردوس

دستور العمل فاصله زمانی تعویض پاره ای از ابزار و اتصالات بیماران

دسته بندی	عنوان	زمان تعویض
سیستم گردش خون	آنژیوکت	هر۷۲ ساعت یکبار- در صورت وجوداندیکاسیون(مثل:فلبیت،درد،قرمزی،نشتی و...)زودترتعویض شود.
	ست سرم	هر ۲۴ ساعت یکبار-بعد از تزریق فرآورده های چربی و آمینواسیدی باهر فراورده تعویض شود.
	میکروست	هر ۷۲ ساعت یکبار،دربخش NICU هر ۲۴ ساعت یکبار ،پس از (TPN)و شیمی درمانی بلافاصله دور انداخته شود
	تری وی- هپارین لاک	هر ۲۴ساعت یکبار
	ست خون	با هربار ترانسفوزیون
	باتل سرم (تزریقی و شستشو)	هر ۲۴ ساعت یکبار
	اکستنشن تیوپ	هر۲۴ ساعت یکبار
	کات دان	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (علائم :عفونت ، انسداد و ..)
	ست تجویز پروپوفول	هر ۱۲ – ۶ ساعت یکبار، یا در صورت تعویض ویال
	کاتتروورید مرکزی	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (علائم :عفونت ، انسداد و ..)
	کاتتر شریان محیطی	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (علائم :عفونت ، انسداد و ..)
	کاتترنافی(ورید وشریان)	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (علائم :عفونت ، انسداد و ..)خارج شده ودیگرجایگزین نشود. کاتترشریان نافی حداکثربعداز۵روزوکاتتروریدنافی حداکثربعداز۱۴روزتعویض شود.
	سرنگ متصل به پمپ انفوزیون	با اتمام داروی داخل سرنگ
	آمپول	بلافاصله بعداز برداشتن مقدارداروی موردنیازدورانداخته شود.
	ویالهای مولتیپل دوز	نگهداری طبق دستورکارخانه سازنده (ویالهای حاوی موادنگهدارنده مثل ویال انسولین ،ویال هپارین و...)
	ویالهای سینگل دوز	بلافاصله بعداز برداشتن مقدارداروی موردنیازدورانداخته شوند(ویالهای بدون موادنگهدارنده مثل :محلولهای قندی هیپرتونیک،نمکی NACL ،آب مقطر،آمپولها)آنتی بیوتیکها جزءویالهای سینگل دوزهستنداما طبق دستورکارخانه سازنده وباحفظ شرایط مطلوب به مدت کم قابل نگهداری هستند.

واحد ایمنی بیمار بیمارستان
شهید دکتر چمران فردوس

دستور العمل فاصله زمانی تعویض پاره ای از ابزار و اتصالات بیماران

سیستم ادراری	سوند ادراری داخلی	در صورت وجود اندیکاسیون بالینی (علائم :عفونت ، انسداد و ..)
	فولی اکسترنال	بنا به نیازبیمار
	کیسه ادراری	درزمان تعویض سوند ادراری داخلی و در صورت وجوداندیکاسیون بالینی (جداشدن ازسوندادراری،آلودگی ، پارگی ونشتی و....)
سیستم تنفسی	لوله تراشه (اندو تراکیال تیوب)	در صورت وجوداندیکاسیون بالینی(درصورتی که شرایط بیماراجازه دهدگذاشتن لوله ازطریق دهان ترجیح دارد) .(پس از گدشت ۷ تا ۱۴ روز ،بسته به شرایط بیمار جهت تراکیاستومی اقدام شود.)
	ساکشن تیوب	اختصاصی برای هر بیمار و تعویض هر ۷ روز یکبار
	کاتتر ساکشن(بازوبسته)	درنوع بازیکبار مصرف-درنوع بسته درصورت آلودگی واضح یاکارکردمعیوب تعویض شود.
	لوله خرطومی ونتیلاتور	اختصاصی برای هر بیمار -در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب تعویض شود.
	فیلتر HME (Heat Moisture Exchanger)	اختصاصی برای هر بیمار-هر۷۲ساعت در صورت آلودگی واضح تعویض شود.
	کاتتروماسک اکسیژن	اختصاصی برای هر بیمار - در صورت آلودگی واضح یا کارکرد معیوب تعویض شود.
	چست باتل	درصورت پرشدن تعویض شود.
سیستم گوارشی	سوند معده	در صورت وجوداندیکاسیون بالینی-درصورت نیازطولانی مدت به NGT بهتراست OGTگذاشته شود.
	سرنگ گاواژ	در پایان هر شیفت کاری
متفرقه	سفتی باکس	پس از پر شدن سه چهارم آن و یا حداکثرپس از۵ روز معدوم گردد.
	چست لید	در صورت وجود اندیکاسیون (جداشدن،کثیف شدن وعدم کارایی)تعویض شود.
	پانسمان کاتترورید مرکزی(CVC)	پوشش گازی استریل هر ۲۴ساعت یکبار ،پانسمان شفاف استریل هر۷روز یکبار -در صورت آلودگی، خیس یا شل شدن پانسمان باید در اسرع وقت تعویض گردد.

واحد ایمنی بیمارستان
شهید دکتر جمران فردوس

مقیاس ارزیابی اقدام به خودکشی

کل نمرات	اقدامات بالینی لازم
تحت نظر در منزل با پیگیری های لازم	0 تا 2
تحت نظر و بستری در بیمارستان	4 تا 3
بستری و تحت نظر ویژه در بیمارستان بر اساس برنامه مراقبتی مطمئن تنظیم شده	6 تا 5
بستری اجباری در بیمارستان با پیش بینی نیروهای ویژه و اختصاصی برای بیمار	10 تا 7

واحد ایمنی بیمار بیمارستان
شهید دکتر چمران فردوس

Scanned with CamScanner

مقیاس ارزیابی اقدام به خودکشی

SAD PERSONS scale

S - sex (جنس) : مردان نمره 1 و زنان نمره صفر (اقدام به خودکشی در بیشتر زنان ناموفق و ناتمام بوده و در بیشتر مردان موفق می باشد)

A-Age (سن) : اقدام به خودکشی در سنین کمتر از 20 سال و بالای 44 سال، نمره 1 تعلق می گیرد.

D-Depression : نمره 1 در صورت وجود افسردگی تعلق می گیرد.

P-attempt Previous : نمره 1 در صورت اقدام به خودکشی ناتمام قبلی تعلق می گیرد

E-abuse Ethanol (اعتیاد به الکل) : نمره 1 در صورت اعتیاد به الکل تعلق می گیرد

R-loss thinking Rational (از دست دادن تفکرات منطقی) : در صورت عدم وجود تفکرات منطقی، نمره 1 تعلق می گیرد.

S-Lacking Supports Social (فقدان حمایت های اجتماعی) : در صورت عدم وجود حمایت های اجتماعی، نمره 1 تعلق می گیرد.

O-Plan Organized (برنامه سازماندهی شده) : اگر برنامه طراحی شده تا مرز خودکشی ء مرگ وجود داشت، نمره 1 تعلق می گیرد.

N-Spouse No (نداشتن شوهر) : در زنان مطلقه، بیوه، تنها یا مجرد، نمره 1 تعلق می گیرد.

S-Sickness (بیماری) : اگر بیماری مزمن، ناتوان کننده و شدید باشد، نمره 1 تعلق می گیرد.

واحد ایمنی بیمار بیمارستان
شهید دکتر حمران فردوس

بیماران با ریسک بالا :

سن بالای ۶۰- سال – سن بین ۴۰-۶۰ و دارای یک فاکتور خطر دیگر ، سابقه VTE درافراد خانواده یا خود بیمار – چاقی – انعقادپذیری اکتسابی یا ارثی – بیماریهای زمینه ای مثل بیماری قلبی – عفونت ، سکته های اخیر بیماریهای التهابی – جراحی سر فمور – آرتروپلاستی زانو – شکستگی لگن – ترومای شدید – صدمات نخاعی یا اعمال جراحی سرطان

بیماران با ریسک پایین :

سن کمتر از ۴۰ سال – مدت زمان بیهوشی کمتر از ۳۰ دقیقه

بیماران با ریسک متوسط :

بیمارانی که تحت عمل جراحی کوچک قرار گرفته است ولی سن بین ۴۰-۶۰ سال دارند و به بیهوشی بیشتر از ۳۰ دقیقه نیاز دارند. قفسه صدری –جراحی اعصاب

Scanned with CamScanner

سیستم طبقه بندی بر اساس شدت بیماری بیماران (۵ سطح مراقبتی)

طبقه ۱ : قادر به مراقبت از خود

طبقه ۲ : مراقبت جزئی

طبقه ۳ : مراقبت متوسط

طبقه ۴ : مراقبت شدید

طبقه ۵ : مراقبت ویژه

طبقه ۱ : قادر به مراقبت از خود (مراقبت حداقل)

۱- فعالیتهای روزانه

- خوردن و آشامیدن ، خود بیمار قادر به خوردن و آشامیدن می باشد و یا نیاز به کمک اندکی دارد .
- نظافت و آراستگی : تقریباً کاملاً به خود متکی می باشد .
- دفعی : خود به خود به تنهایی یا تقریباً تنها به توالت می رود و بی اختیاری ادراری ندارد .
- حرکت : بیمار به خود متکی است .

۲- سلامت عمومی

- بیمار جهت یک پروسیجر تشخیصی ، انجام یک پروسیجر یا جراحی ساده یا جزئی پذیرفته شده است .

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی :

- آموزش روتین برای پروسیجر ساده
- آموزش بعد از ترخیص از بیمارستان
- واکنشهاس غیر و معمول عاطفی ندارد
- بیمار ممکن است نسبت به آگاه شدن به زمان ، مکان و شخص در هر شیفت نیاز داشته باشد .

۴ - درمان ها و داروها :

- ندارد یا داروها و درمانهای ساده دارد .

طبقه ۲: مراقبت جزئی (مراقبت نسبی)

۱ فعالیتهای روزانه

- خوردن و آشامیدن ، بیمار می تواند به تنهایی غذا بخورد ولی نیازمند کمک در آماده کردن غذا تشویق به خوردن و پوزیشن گرفتن است .
- نظافت و آراستگی : اکثریت موارد بدون کمک یا با کمک جزئی جهت بیمار انجام می گیرد .
- دفعی : نیاز به کمک جهت رفتن به توالت یا استفاده از لوله ادراری دارد . بی اختیاری ادراری یا تجربه بی اختیاری استرسی ادراری یا قطره قطره ادرار کردن را ندارد .
- حرکت : به خودی خود یا با کمک جزئی حرکت می کند .

۲- سلامت عمومی

- بیمار علائم و نشانه های جزئی بیشتر از یک بیماری متوسط دارد . نیازمند مانیتورینگ ، گرفتن علائم حیاتی
- درناژ و انفوزیون بدون عوارض جانبی

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی :

- نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی ۱۰-۵ دقیقه در هر شیفت است .
- بیمار ممکن است به صورت جزئی گیج بوده ، حالت تهاجمی داشته باشد اما به خوبی توسط داروها ، آگاه نمودن مکرر یا محدود کننده کنترل می گردد .

۴ - درمان و داروها :

- ۳۰-۲۰ دقیقه در هر شیفت نیازمند ارزیابی از نظر موثر بودن دارو و درمان می باشد .

CamScanner

- بیمار ممکن است هر ۲ ساعت نیاز به بررسی وضعیت مغزی یا شناختی را داشته باشد .

طبقه ۳ : مراقبت متوسط (مراقبت کامل)

۱- فعالیتهای روزانه

- خوردن و آشامیدن ، بیمار ممکن است توانایی بلعیدن و یا قورت دادن را داشته باشد اما نیازمند کمک به خوردن و آشامیدن است .
- نظافت و آراستگی : به تنهایی قادر به انجام بیشتر این فعالیتها نمی باشد .
- دفعی : نیاز به دریافت و برداشت لگن و لوله ادراری را دارد .
- حرکت : به طور کامل وابسته می باشد و نیازمند چرخاندن توسط یک نفر می باشد و تنها میتواند به صورت جزئی بچرخد .

۲- سلامت عمومی :

- بیمار علائم حاد دارد که ممکن است کاهش یابد .
- نیازمند مانیتورینگ و ارزیابی وضعیت فیزیولوژیکی یا وضعیت عاطفی هر ۲ تا ۴ ساعت است .
- درناژ مداوم یا انفوزیون که نیازمند مانیتورینگ هر ۱ ساعت است را دارد .

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی :

- نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی ۳۰-۱۰ دقیقه هر هر شیفت است .
- گاهی در مقابل به آموزش ها مقاومت می نماید و یا سریعاً درک می نماید .
- بیمار ممکن است گیج،آژیته باشدامانسبتاً به خوبی توسط دارو،آگاهی دادن مرتب یامحدود کننده کنترل می گردد .

۴- درمان ها و داروها :

- ۶۰-۳۰ دقیقه در هر شیفت نیازمند مشاهده مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک است .
- بیمار ممکن است هر ۱ ساعت نیاز به بررسی وضعیت مغزی یا شناختی را داشته باشد .

۴- طبقه ۴ : مراقبت شدید : (مراقبت ویژه تعدیل یافته)

۱- فعالیتهای روزانه :

- خوردن و آشامیدن : بیمار نمی تواند به تنهایی غذا بخورد به سختی می بلعد و یا قورت می دهد . ممکن است نیازمند تغذیه از راه لوله معده داشته باشد .
- نظافت و آراستگی :کلیه مواردمانندحمام کردن،مراقبت ازموها،مراقبت از دهان را بیمار کاملا با کمک انجام می دهد .
- دفعی : بیشتر از ۲ بار در هر شیفت بی اختیاری دارد .
- حرکت:خود بیمار نمی تواند بچرخد ، جهت چرخیدن در تخت نیازمند ۲ نفر می باشد .

۲- سلامت عمومی :

- به شدت بیماراست و دچار علائم حادی مانند خونریزی یا کاهش مایعات بدن ، حملات تنفسی حاد و ... می باشد .
- نیازمند مانیتورینگ و ارزیابی

۳- آموزش و حمایت عاطفی و روانی :

- نیازمند آموزش و حمایت عاطفی و روانی بیشتر از ۶۰ دقیقه در هر شیفت است .
- بیماران ممکن است گیج،بی قراروعصبی وآژیته بوده وباداررومحدودکننده و یاآگاهی دادن مکررکنترل نمی گردد .

۴- درمان ها و داروها :

- نیازمند بیشتر از ۶۰ دقیقه مشاهده مکرر برای اثرات جانبی یا واکنشهای آلرژیک است .
- نیازمند مشاهده و ارزیابی وضعیت مغزی و شناختی هر ۱ ساعت دارد .

۵- طبقه ۵ : مراقبت ویژه :

- نیازمند مشاهدات دائم می باشد و در هر شیفت مانیتورینگ مداوم نیاز دارد . مانند مراقبت از بیمار تحت ونتیلاتور

CamScanner